

VILMA ZULEIDE PAVAO PENTEADO

MEDICAMENTOS:				
SINTOMAS/QUEIXAS				
BANHEIRO				
HORA QUE ACORDA				
HORA QUE DORME				
SONECA DURANTE O DIA				
HORARIO DAS REFEIÇÕES				
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:	
20	P = 8 cmH ₂ O			
04	IAH = 1.2			
22	M. de uso: 6h			
Apresentou cefaleia após uso Prisma				
04/05	P = 8 cmH ₂ O.			
22	IAH = 0,3 e/min.			
M. de uso: 6h30'				
Melhora da dor de cabeça.				
Apresentou queda da PA				
20/08	P = 8 cmH ₂ O			
22	IAH = 1.1			
02/06	P = 8 cmH ₂ O			
25	IAH = 0,8 e/eu			
mas utilizou pouco.				
09/06	P = 8 cmH ₂ O			
25	IAH = 0,3 e/eu			
M. de uso: 7h40'				
pressão = 9.4 e/eu.				

Nome: VILMA ZULEIDE PAVÃO PENTEADO

Data de Nascimento: 21-8-1940

IMC: 27,93

Sexo: Feminino

Data do exame: 10-06-2024

Peso: 62 kg

Altura: 1,49 m

Médico: DRA. MARIA CECILIA MENEZES

PIRES

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 10-06-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 491,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 29,5 e 213,5 minutos. O tempo total de sono foi de 375,0 min, eficiência de 76,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 57,5%; estágio N3: 18,9%; sono REM: 21,6%. O índice de despertares foi de 24,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 47,0/hora, sendo 54 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 158 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 83%, permanecendo 1,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 64 - 94 bpm e NREM de 62 - 96 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 47,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=83%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

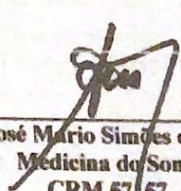
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57